

18/08

Joh

INDICADO POR: Angélica Gomes

X ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

JULIO PASSERI NETOIDADE: 67 PESO: 94 ALTURA: 1,83 PROFISSÃO: ArquitetoSINTOMAS: Ronco; Engasgo à noite barulho por cima; Despertar à noite 4x
Zumbido; SonolênciaQUEIXAS: Acorda pouco cansado à vezes, tontura; Deficit AuditivoMEDICAMENTOS: Nublok (HAS), Ventigium → substitui por outro; Rosuvastatina
SertralinaMÉDICO: Dra. Dis Zampieri Goulart

MARCAPASSO: () S () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x semana. (Musculação / Estrela)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22h30' 23h30' HORA QUE ACORDA: 06h30' 07h

COCHILO () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: X S () NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA X N nao poucoFUMO: () S () MAÇO/DIA X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO:

BANHEIRO/NOITE: 1x / 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 32 elh SPO2: 82%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Vai parar Nutri → Gordura fígado / Atividade física

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () S) CARDÍACA Geriatra (S)

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

30/06/2025 Análise auto 4-10 max D.Wear (G)07/07/2025 P: 7,9 cmH₂O P95: 9,8 cmH₂O Sentiu Bem.

IAH = 1,3 elh

muco = 8h30'

fuga = 13 l/min.

Fixo Duras 8,0 cmH₂O

Silvia

14/07/2025 P = 8,0 cmH₂O.

IAH = 1,4 elh. A0: 0,0 lip: 0,6.

muco = 6h50 min

fuga = 30 l/min.

P: 7,6 cmH₂O

Silvia

28/07/2025 P: 7,6 cmH₂O

IAH = 0,8 elh

muco = 7h00

fuga = 28 l/min.

Bem adaptado; deixa escape no pulmão

componha prong pillow (M).

toco filtro

Silvia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: JULIO PASSERI NETO			
Sexo: M	Idade: 67 anos	Peso: 94 Kg	Altura: 1.83 m
IMC: 28.1	Data do Exame: 23/05/2025	Exame: 00600_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:20 PM horas e encerrado às 5:32:03 AM horas, com latência para o sono de 4 minutos e latência para o sono REM de 367 minutos. O tempo total de sono foi de 398.0 minutos, com eficiência do sono de 96.1%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1.3%	Até 5%
Estágio 2	84.2%	45 - 55%
Estágio 3	8.3%	> 15%
Sono REM	6.3%	20 - 25%
Eficiência do sono	96.1%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 12 minutos ocorreram **198 despertares (índice de 29.8 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 55 bpm, a maior de 70 bpm e a menor de 48 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 213 eventos respiratórios, sendo 0 central e 213 obstrutivos. Sendo 185 apnéias, 28 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 32.1/hora**, sendo 27.9 apnéia/hora e 4.2 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos-respiratórios foi de 19.4 e a duração máxima de 31.5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 62.4/hora, sendo 60.0 apnéia/hora e 2.4 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%**, sendo a saturação média de **94%**, a maior de **98%** e a mínima de **81%**, permanecendo 9.4 minutos (2.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 214 dessaturações. Índice de dessaturações: 32.6/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 65.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 30.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Guilherme Salomon de Dominicis
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 130842

Dra. Lis Bastos Zampier Goulart

CRM: 179501SP - Geriatria e gerontologia

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: Julio Passeri Neto

CPF: 601.659.367-20

Data e hora: 11/06/2025 - 10:32:35

Encaminhamento

Oriento uso de CPAP devido Apneia Obstrutiva do Sono de intensidade Acentuada.

Estágio do sono	%	Nº de eventos
Estágio 1	1.2%	AM 0.2
Estágio 2	64.2%	48 - 65%
Estágio 3	8.3%	> 15%
Sono REM	26.3%	20 - 25%
Estágio do sono	99.9%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono - WAO 12 minutos ocorreram 188 despertares (índice de 29.8/hora).

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 55 bpm, a maior de 70 bpm e a menor de 42 bpm. Foram identificados 0.0 movimentos periódicos de membros inferiores, e 0.0 horas associadas a despertares.

Ocorreram 213 eventos respiratórios, sendo 0 central e 213 obstrutivos. Sendo 185 apnéias, 28 hipopnéias e 0 RERAS. O índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 32.7/hora, sendo 32.9 apnéias/hora e 4.2 hipopnéias/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 18.4 s e duração máxima de 31.5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A saturação basal da oximetria foi de 94%, sendo a saturação média de 94%, a maior de 94% e a mínima de 81%. Permanecendo 9.4 minutos (2.3%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 214 dessaturações. Índice de dessaturações: 32.8/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 65.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 30.0/hora.

Resumo dos resultados

Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo. Saturações da Oximetria: 94%.

Lis B. Zampier Goulart
CRM/SP 179501
Médica - Geriatria